

anestesia 2

03 de Outubro de 2026

Questão 01

HCPA-RS 2026 ACESSO DIRETO

Paciente de 32 anos, casada, G2P2 (sem registro de intercorrências nas gestações), com IMC de 33 kg/m², não tabagista, sem doenças crônicas e sem limitações funcionais, será submetida a laqueadura tubária por via transvaginal. Vinha fazendo uso apenas de acetato de medroxiprogesterona trimestral para anticoncepção. O Termo de Consentimento Informado já se encontrava assinado por ela e pelo médico assistente. Assinale a alternativa que contempla o conjunto correto de informações em relação ao risco anestésico, à avaliação pré-operatória e ao Termo de Consentimento Informado.

- A.** Paciente Asa I - Não são necessários exames pré-operatórios. - O Termo de Consentimento deve ser assinado também pelo esposo.
- B.** Paciente Asa I - Deverão ser solicitados hemograma e hemoglobina glicada no pré-operatório. - O Termo de Consentimento não precisa ser assinado pelo esposo.
- C.** Paciente Asa II - Deverão ser solicitados hemograma e hemoglobina glicada no pré-operatório. - O Termo de Consentimento deve ser assinado também pelo esposo.
- D.** Paciente Asa II - Não são necessários exames pré-operatórios. - O Termo de Consentimento não precisa ser assinado pelo esposo.

Questão 02

SUS-PE 2012 ACESSO DIRETO

Sobre os anestésicos locais, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A.** Agem bloqueando o potencial de ação dos impulsos nervosos através da inibição do influxo sódio nos canais de sódio.
- B.** A adição de adrenalina prolonga seu tempo de ação, porém aumenta sua toxicidade sistêmica.
- C.** A bupivacaína é mais potente e duradoura do que a lidocaína, embora com início de ação mais lenta.

D. A bupivacaína tem maior toxicidade cardiovascular, e a lidocaína, neurológica.

E. São menos efetivos em tecidos infectados e/ou inflamados.

Questão 03

HOS-SP 2024 ACESSO DIRETO

Há mais de 50 anos, a Sociedade Americana de Anestesiologia, apoiada na avaliação clínica pré-operatória, estabeleceu uma classificação do estado físico do doente, que tem implicações em relação ao ato operatório e que ainda hoje é intensamente utilizada. Posteriormente, foi incluída a classificação de ASA 6, representada por pacientes com qual das características a seguir?

- A.** Criança recém-nascida portadora de malformação cardíaca grave.
- B.** Gestante em parada cardíaca candidata a cesárea pos mortem.
- C.** Presença de morte cerebral e candidato a doação de órgãos.
- D.** Mínima chance de sobrevivência; operação como último recurso.
- E.** Doença sistêmica incapacitante com risco de morte com ou sem operação.

Questão 04

PSU-MG 2014 ACESSO DIRETO

A psicóloga C.S.D., de 32 anos, interna-se para operação de cesariana de urgência. Em relação aos cuidados anestésicos na grávida, assinale a afirmativa ERRADA:

- A.** O risco aumentado de aspiração durante a indução anestésica pode ser amenizado com a utilização de intubação em sequência rápida e da manobra de Sellick.
- B.** Deve-se monitorar a oximetria de pulso, capnografia e pressão arterial, pois a hipercapnia materna pode provocar acidose fetal.

C. Deve-se utilizar oxigenoterapia suplementar no intuito de manter a saturação de O₂ da hemoglobina em 90%.

D. Caso ocorra hipotensão durante a indução anestésica, deve-se manter fluxo sanguíneo placentário adequado às custas de reposição volêmica e, se necessário, usar drogas vasoativas.

Questão 05

PSU-MG 2021 ACESSO DIRETO

Com frequência, na prática clínica, o cirurgião utiliza a associação de adrenalina aos anestésicos locais. Essa associação vai determinar o(a):

- A.** Aumento da ligação protéica do anestésico local
- B.** Aumento do pKa do anestésico local
- C.** Redução da concentração plasmática do anestésico local
- D.** Redução da latência anestésica

Questão 06

ABC-SP 2018 ACESSO DIRETO

Dentre os efeitos sistêmicos provocados pela raquianestesia, assinale a alternativa correta:

- A.** Os efeitos gastrintestinais do bloqueio subaracnóideo são devidos ao bloqueio parassimpático
- B.** Um bloqueio sensitivo em nível de T6 não provoca alterações cardiocirculatórias importantes
- C.** O bloqueio da condução da dor proporciona condições satisfatórias para realização de cirurgias
- D.** O principal efeito cardiovascular do bloqueio subaracnóideo é a vasoconstrição periférica

Questão 07

UNCISAL 2020 ACESSO DIRETO

Qual é o melhor método (gold standard) para confirmar a posição da cânula na traqueia?

- A.** Ausculta do tórax e abdome
- B.** Detector colorimétrico de CO₂ expirado
- C.** Visualização da condensação de gás na cânula durante

a expiração

D. Percussão do tórax

E. Presença de vapor de água na cânula orotraqueal

Questão 08

SES-PE 2025 ACESSO DIRETO

Homem, 53 anos. Vítima de espancamento. Apresenta-se combativo e com sinais de trauma de face. Oferecido O₂ com máscara e saturação ficou em 90%. Após 20 min, desorientou e SatO₂ foi para 85%. Indicado TC de crânio após intubação com sequência rápida. Em relação a esse procedimento, qual sedativo abaixo, de acordo com o ATLS, não afeta negativamente a pressão arterial e intracraniana?

- A.** Succinilcolina.
- B.** Etomidato.
- C.** Alfentanila.
- D.** Rocurônio.
- E.** Propofol.

Questão 09

FAMEMA 2024 ACESSO DIRETO

Com relação ao procedimento de sedação e analgesia, assinale a alternativa correta.

- A.** A) A ketamina possui uma importante ação ansiolítica e doses repetidas se acumulam no tecido adiposo.
- B.** B) Pacientes idosos ou com disfunção hepática estão sob maior risco de efeitos pronunciados e prolongados com o uso de fentanil.
- C.** C) Midazolam é a droga que mais efeito dissociativo (estado de transe) causa.
- D.** D) Ação do propofol inicia-se em 10-15 minutos, e tem sua duração média de 60 minutos.

Questão 10

INEP 2016 REVALIDA

Uma mulher com 28 anos de idade, com classificação pré-anestésica ASA I, será submetida a um procedimento de dermolipectomia abdominal sob anestesia geral.

paciente foi monitorizada com eletrocardiograma, oximetria de pulso e capnografia. Com relação aos procedimentos relacionados à anestesia geral, assinale a alternativa correta.

- A.** (Deve-se optar pela indução inalatória porque ela proporciona menor desconforto ao paciente e permite sua rápida entubação.
- B.** (A profundidade anestésica, se utilizada a quetamina, deve ser monitorada pela avaliação da pressão arterial, da sudorese e do tamanho de pupilas.
- C.** (A opção pela indução endovenosa é limitada por ser mais lenta e desconfortável para o paciente e por não proporcionar relaxamento muscular adequado.
- D.** (Caso a anestesia seja inalatória, há a necessidade de avaliar, além da pressão arterial e da frequência cardíaca, o relaxamento muscular no monitoramento da profundidade anestésica.

Questão 11

UNICAMP 2021 ACESSO DIRETO

O bloqueador neuromuscular indicado para intubação em sequência rápida em paciente com estômago cheio é:

- A.** A. Pancurônio.
- B.** B. Atracurio.
- C.** C. Succinilcolina.
- D.** D. Vecurônio.

Questão 12

PUCSP 2019 ACESSO DIRETO

Qual opção é menos segura para garantir uma via aérea difícil?

- A.** Laringoscopia direta e intubação oral.
- B.** Intubação endotraqueal com broncoscopia.
- C.** Cricotiroidostomia.
- D.** Máscara laríngea.

Questão 13

UEPA 2022 ACESSO DIRETO

São preditores de via aérea difícil para intubação traqueal, EXCETO:

- A.** Obesidade.
- B.** Abertura da boca < 3 dedos.
- C.** Mallampati III.
- D.** Intubação traqueal prévia.
- E.** Restrição à mobilidade cervical.

Questão 14

SES-PE 2022 ACESSO DIRETO

Intubação em sequência rápida tem sido a técnica padrão para o manuseio da via aérea na emergência e se baseia na indução com sedativo de ação rápida, de um bloqueador neuromuscular. Com relação a essa técnica, assinale a alternativa CORRETA

- A.** Trata-se da técnica de escolha para pacientes com via aérea difícil, quando o médico não tem grande experiência.
- B.** Está especialmente indicada quando existe urgência na intubação, como em pacientes com hipoxemia ou acidose metabólica graves.
- C.** O uso de succinilcolina como bloqueador neuromuscular está formalmente contraindicado em pacientes com risco de desenvolver hipercalemia.
- D.** O etomidato não deve ser empregado em pacientes com instabilidade hemodinâmica
- E.** Uma das principais desvantagens dessa técnica é o aumento do risco de broncoaspiração.

Questão 15

SURCE 2021 ACESSO DIRETO

Uma paciente foi submetida a uma gastrectomia parcial sob anestesia geral e relata aos familiares e médico que "lembra" de eventos ocorridos no transoperatório. A consciência operatória poderia ser minimizada através de qual das seguintes ações?

- A.** Manutenção venosa com morfina.

- B. Manutenção do BIS em torno de 50–60.
- C. Reaplicação de pancurônio ao final da cirurgia.
- D. Manutenção da PAM em torno de 60–70 mmHg.

Questão 16

USP-SP 2022 ACESSO DIRETO

Homem de 65 anos de idade é admitido por insuficiência respiratória aguda no Pronto-Socorro. Durante o atendimento inicial, evolui com piora do padrão respiratório e da hipoxemia, optando-se por intubação orotraqueal. Nesse momento, a frequência respiratória é de 40 irpm, saturação de oxigênio de 88% com máscara não reinalante a 15L/min, frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x30 mmHg. Considerando a disponibilidade das quatro drogas abaixo, qual é a medicação de escolha para realizar a sedação deste paciente?

- A. Fentanil.
- B. Midazolan
- C. Propofol.
- D. Etomidato.

Questão 17

HCPA-RS 2022 ACESSO DIRETO

Paciente de 68 anos, que se encontrava hospitalizado porque será submetido a cirurgia de urgência para ressecção de tumor intracraniano, apresentou rebaixamento do sensório e vômitos. Na avaliação pré-anestésica, foram identificadas cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, classe III, que vinham em tratamento regular. Que fármaco, dentre os abaixo, é o de escolha como indutor para a anestesia?

- A. Propofol.
- B. Fentanila.
- C. Etomidato.
- D. Dexmedetomidina.

Questão 18

UFPI 2015 ACESSO DIRETO

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que

tem por finalidade criar um acesso à via aérea do paciente, comunicando a traqueia cervical ao exterior. É fundamental conhecer as indicações para este procedimento. Dentre essas indicações, estão, EXCETO:

- A. Insuficiência respiratória obstrutiva por neoplasia de vias aéreas.
- B. Insuficiência respiratória infiltrativa provocada por tumor dos seios da face.
- C. Insuficiência respiratória provocada por traumatismo de face ou trauma de laringe.
- D. Paralisia bilateral de cordas vocais por lesão do nervo recorrente.
- E. Doenças neurológicas que prejudicam a mecânica ventilatória.

Questão 19

SES-PE 2020 ACESSO DIRETO

Homem, 63 anos, sofreu trauma abdominal fechado por atropelamento. Foi indicado laparotomia de emergência. Você participa da equipe anestésica que irá realizar o procedimento. A anestesista sugere que a entubação será difícil e adota várias medidas para o sucesso da obtenção da via aérea. Assinale a alternativa que contém métodos de avaliação de uma via aérea difícil.

- A. Mallanpati e ASA
- B. LEMON e Cormack-Lehane
- C. Mallanpati e ASIA
- D. LEMON e Hinchey
- E. MOANS e Cormack – Lehane

Questão 20

HIAE-SP 2025 ACESSO DIRETO

Um homem de 45 anos, sem comorbidades conhecidas e com antecedente de alergia a dipirona, foi submetido a uma colecistectomia laparoscópica. No primeiro dia de pós-operatório, ele relata dor abdominal difusa com uma pontuação de 5/10 na escala de dor. A analgesia multimodal, incluindo paracetamol e cetoprofeno, não aliviou suficientemente a dor. O paciente apresenta dificuldade para respirar profundamente devido ao desconforto. Exames de imagem e outros testes descartaram quaisquer complicações cirúrgicas. A equipe médica agora busca

otimizar o manejo da dor pós-operatória. Qual é o próximo passo mais apropriado no manejo da dor para esse paciente?

- A.** Aumentar a dose de paracetamol para maximizar seu efeito analgésico.
- B.** Iniciar um opioide de ação curta, como tramadol, para controle adicional da dor.
- C.** Administrar relaxantes musculares por via oral para reduzir o desconforto abdominal.
- D.** Iniciar morfina subcutânea, para controle adicional da dor.

Questão 21

PUC-PR 2024 ACESSO DIRETO

Paciente feminina, 22 anos, 38 semanas de gestação, encaminhada para avaliação pré-anestésica para cesariana eletiva. Nega doenças prévias, nega uso de medicamentos, gestação foi sem intercorrências e seu pré-natal foi de baixo risco. Sobre esse caso e a classificação de risco cirúrgico da ASA (American Society of Anesthesiologists), marque a alternativa CORRETA.

- A.** Paciente pode ser classificada como ASA 1, pois é jovem, não tem comorbidades prévias, não faz uso de medicações e a gestação não é uma doença.
- B.** A ASA não se posiciona sobre gestação na sua escala de risco cirúrgico.
- C.** Paciente é classificada como ASA 2, pois as alterações fisiológicas da gestação podem aumentar o risco cirúrgico.
- D.** Somente gestantes de alto risco são consideradas ASA 2.
- E.** Paciente é classificada como ASA 2, já que a cesariana tem maior risco de sangramento, se optasse por parto normal, seria ASA 1.

Questão 22

HIAE-SP 2019 ACESSO DIRETO

Em relação aos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, é correto afirmar:

- A.** As incisões de biópsias excisionais devem ser realizadas respeitando as linhas de força da pele, para melhor resultado estético.
- B.** A superdosagem de anestésicos locais pode causar

sintomas neurológicos, como convulsões e, mesmo, parada respiratória.

- C.** Em procedimentos de cantoplastia, é recomendado utilizar anestésicos locais com adição de vasoconstritor, para diminuir o sangramento.
- D.** Nas drenagens de abscessos com processo inflamatório intenso, não há benefício em usar anestesia local.
- E.** As lesões cutâneas suspeitas de malignidade devem ser biopsiadas com margem de, no mínimo, 1,0 cm, para avaliação histológica inicial adequada.

Questão 23

SES-GO 2024 ACESSO DIRETO

Alguns fatores alteram a dispersão dos anestésicos na anestesia subaracnóidea, além da baricidade da solução utilizada. Estas soluções apresentam diferenças em sua densidade e atuação, sendo que:

- A.** As isobáricas tendem a produzir bloqueios anestésicos mais baixos quando o paciente é colocado em posição supina.
- B.** As isobáricas tendem a dispersar cranialmente quando o paciente é colocado em posição de cefalodeclive.
- C.** As hiperbáricas são imunes de influência da posição ortostática.
- D.** As hiperbáricas produzem bloqueios mais duradouros que as soluções isobáricas.

Questão 24

ENARE 2021 ACESSO DIRETO

Um paciente com indicação de cirurgia apresentou, logo após a anestesia, taquicardia, temperatura elevada, arritmia e espasmo do músculo masseter. Sobre o provável diagnóstico desse quadro, suas características e manejo, assinale a alternativa correta.

- A.** Trata-se de choque séptico que deve ser tratado com infusão imediata de antibiótico.
- B.** Trata-se de hipotermia maligna e deve ser administrado Dantrolene.

- C. Trata-se de hipertermia maligna, condição autossômica dominante.
- D. Trata-se de choque séptico refratário e deve ser administrado sevoflurano.
- E. Trata-se de hipertermia maligna e deve ser administrada succinilcolina.

Questão 25

UNIFESP 2017 ACESSO DIRETO

Em relação à anestesia infiltrativa, qual é a afirmativa CORRETA?

- A. A dose máxima de procaína é 14 mg/kg.
- B. A dose máxima de lidocaína com epinefrina (1:200.000) é de 14 mg/kg.
- C. A duração aproximada de lidocaína é de 4 a 5 horas.
- D. A duração aproximada de procaína é de 3 a 5 horas.
- E. A dose máxima de lidocaína é 7 mg/kg.

Questão 26

UFS 2020 ACESSO DIRETO

Um paciente de 18 anos, previamente hígido, está no pós-operatório imediato de hernioplastia inguinal, com anestesia peridural. Refere dor crescente em hipogástrio. Está ansioso e agitado. Pulso 110bpm, PA 120 x 90mmHg. Palpa-se massa dolorosa em hipogástrio. Descompressão brusca: negativa. A ferida cirúrgica tem bom aspecto. Conduta:

- A. Ultrassom de abdome.
- B. Passagem de sonda vesical.
- C. Tomografia de abdome com contraste venoso.
- D. Abertura e revisão da incisão.

Questão 27

USP-SP 2019 ACESSO DIRETO

Mulher, 28 anos de idade, antecedente cirúrgico, está realizando avaliação pré-anestésica para correção de hérnia inguinal. Relata ao anesteista que não sabe se possui alergia a medicamentos, mas possui alergia a pêssigo, kiwi e mandioca. Qual outro tipo de alergia deve ser investigado

antes da realização do procedimento?

- A. Lidocaína.
- B. Cetorolaco.
- C. Látex cirúrgico.
- D. Cefazolina.

Questão 28

PSU-MG 2024 ACESSO DIRETO

O cirurgião tem a possibilidade de utilizar diferentes anestésicos locais e seus adjuvantes com o objetivo de fornecer anestesia e analgesia ao paciente. Ao se comparar a lidocaína com a ropivacaína é CORRETO afirmar:

- A. A lidocaína apresenta menor toxicidade cardíaca que a ropivacaína.
- B. A lidocaína possui maior pKa apresentando, portanto, menor latência anestésica.
- C. A ligação protéica da ropivacaína é alta, sendo responsável por sua reduzida latência anestésica.

D. A ropivacaína é habitualmente comercializada em associação com a adrenalina para aumentar a duração de ação.

Questão 29

UNIFESP 2022 ACESSO DIRETO

Homem, 75 anos de idade, é admitido no PS com insuficiência respiratória por covid-19. Apresenta antecedente de coronariopatia e está em uso de betabloqueador. Exame físico = PA 100 x 45 mmHg, FC = 45 bpm e SatO₂ = 85%. Em relação à indução para a intubação traqueal, é correto afirmar que

- A. Deve ser utilizado succinilcolina ou rocurônio como bloqueador neuromuscular.
- B. O alfentanil é a melhor opção de opioide.
- C. O propofol deve ser administrado de forma rápida para hipnose adequada.
- D. Não é necessário o uso de opioides devido ao uso crônico de betabloqueador.

Questão 30

Anulada

HCPA-RS 2024 ACESSO DIRETO

Paciente de 2 anos foi trazido à Emergência por febre, irritabilidade, má perfusão periférica e presença de petéquias no abdômen e nos membros inferiores. Considerando que será realizada punção lombar, que medicamento, dentre os abaixo, é o recomendado por seu melhor efeito sedativo e segurança de uso?

- A. Cetamina.
- B. Codeína.
- C. Diazepam.
- D. Dexmedetomidina.

Questão 31

SURCE 2023 ACESSO DIRETO

Uma menina de 8 anos é admitida para realização de uma cirurgia eletiva para remoção de amígdalas sob anestesia geral. Sua mãe informa que sua última refeição foi cerca de 150ml de suco de laranja e um sanduíche de presunto, às 6:00 da manhã. Com relação ao jejum pré-operatório, a partir de que horas o anesthesiologista poderá iniciar a indução anestésica da criança?

- A. A partir das 8:00.
- B. A partir das 10:00.
- C. A partir das 12:00.
- D. A partir das 14:00.

Questão 32

PUCSP 2023 ACESSO DIRETO

Deve-se evitar a intubação nasotraqueal, quando um paciente apresenta qual dos seguintes sinais?

- A. Angioedema.
- B. Varizes esofágicas.
- C. Equimose retroauricular.
- D. Paralisia das cordas vocais.

Questão 33

FAMEMA 2026 ACESSO DIRETO

Considerando-se sedação e analgesia de procedimentos não eletivos, assinale a alternativa correta.

- A. Midazolam tem efeito cardiodepressor importante.

B. Tempo de início de ação do etomidato é, em geral, de 2 a 5 minutos.

C. Tempo de ação médio da cetamina é de 30 a 60 minutos.

D. A ocorrência de quadro de hipotensão arterial é frequente quando do uso de fentanil.

Questão 34

UNICAMP 2023 ACESSO DIRETO

Durante a laringoscopia na intubação orotraqueal é solicitado, para um integrante da equipe, realizar uma pressão no sentido posterior, superior e para a direita na laringe. A FINALIDADE PRINCIPAL DESTA MANOBRA É:

- A. A. Comprimir o esôfago contra a coluna.
- B. B. Auxiliar na visualização das cordas vocais.
- C. C. Determinar a classificação de Mallampati.
- D. D. Evidenciar grau de obstrução da via aérea.

Questão 35

UFMT 2017 REVALIDA

Sobre a anestesia subaracnoídea, assinale a afirmativa correta.

- A. O espaço subaracnoídeo só pode ser abordado pela via mediana.
- B. A punção no interespaço L5-S1 é a mais segura.

C. Um dos fatores que influenciam a dispersão das soluções anestésicas injetadas no espaço subaracnoídeo é a densidade da solução em relação à densidade do líquido

D. A cefaleia pós-anestesia subaracnoídea se agrava em decúbito dorsal.

Questão 36

UNIFESP 2017 ACESSO DIRETO

Paciente é submetido à laparotomia exploradora sob anestesia geral venosa total. É colocado sob ventilação mecânica após indução e intubação traqueal. Dois minutos após, o valor do capnógrafo começa a apresentar queda lenta e progressiva. Este efeito é por:

- A. Depressão da ventilação.

- B. Volume corrente baixo.
- C. Frequência respiratória baixa.
- D. Hipotensão arterial.
- E. Intubação esofágica.

Questão 37

SURCE 2013 ACESSO DIRETO

"Paciente masculino, 70 anos, com angina instável e obstrução parcial grave das três principais coronárias, deverá ser submetido à revascularização do miocárdio. É diabético, utilizando hipoglicemiantes orais, com glicemia capilar de jejum de 350 mg/dl e Cr de 2,8 mg/dl, em acompanhamento irregular na unidade de saúde. Apresenta ainda hipertensão arterial sistêmica e, no exame físico atual, PA = 180 x 110. Qual a classificação de estado físico deste paciente (P) de acordo com o que preconiza a Sociedade Americana de Anestesiologia?"

- A. P1.
- B. P2.
- C. P3.
- D. P4.
- E. P5.

Questão 38

PUC-PR 2023 ACESSO DIRETO

Qual das drogas abaixo pode ser utilizada na intubação de sequência rápida no trauma e atua como um bloqueador neuromuscular?

- A. Propofol.
- B. Etomidato.
- C. Fenatil.
- D. Succinilcolina.
- E. Midazolam.

Questão 39

SCM-BH 2018 ACESSO DIRETO

As formas de acesso à via aérea principal devem ser do conhecimento de todo médico, posto que é um procedimento que salva vidas, em qualquer ambiente de assistência à saúde. Na técnica correta para entubação, com que mão o laringoscópio

deve ser segurado?

- A. Com a mão dominante do operador.
- B. Sempre com a mão direita.
- C. Com qualquer mão.
- D. Sempre com a mão esquerda.

Questão 40

UEPA 2026 ACESSO DIRETO

Uma mulher de 34 anos, previamente saudável, é submetida a colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia geral com sevoflurano e succinilcolina. Cerca de 30 minutos após o término do procedimento, ainda na sala de recuperação anestésica, desenvolve taquicardia (160 bpm), hipertensão inicial seguida de hipotensão (70/40 mmHg), rigidez generalizada e temperatura central de 40,5°C. O anestesista relata aumento progressivo e inexplicado da concentração máxima de CO₂ exalada ao final da expiração e corresponde (ETCO₂) intraoperatório. A gasometria arterial e exames mostram: pH- 7.10; PaCO₂- 75mmHg; PaO₂- 103mmHg; HCO₃⁻- 13mEq/L; Lactato- 8,1 mmol/L; CPK- 9.500U/L e K⁺ 7,8 mEq/L. ECG demonstra QRS largo, ondas T apiculadas e extrassístoles ventriculares. A equipe se prepara para intubação de resgate e administração de gluconato de cálcio para estabilização de membrana. A próxima conduta prioritária que realmente muda a fisiopatologia do quadro, é:

- A. Gluconato de cálcio endovenoso.
- B. Dantrolene endovenoso.
- C. Bicarbonato de sódio em bolo endovenoso.
- D. Adrenalina em infusão contínua.
- E. Dipirona em infusão contínua.

Questão 41

USP-RP 2022 ACESSO DIRETO



Radiografia de membro superior

Menino de 6 anos de idade apresentou queda da própria altura sobre o membro superior esquerdo, evoluindo com dor e edema no cotovelo. Realizada radiografia ilustrada na figura abaixo que evidenciou luxação do cotovelo esquerdo. Mãe refere que criança tem asma mas que está controlada com uso de beclometasona via inalatória. Nega internações prévias e última refeição foi há 8 horas. Neste caso qual é a opção medicamentosa mais adequada para preparar a criança para o procedimento?

- A. Midazolam
- B. Clonidina
- C. Propofol
- D. Cetamina.

Questão 42

INEP 2015 REVALIDA

Uma menina de 7 anos de idade é levada à Unidade Básica de Saúde devido a acidente doméstico com ferimento corto-contuso do antebraço direito. A lesão tem, aproximadamente, 12 cm de extensão, bordas regulares com sangramento discreto e não ultrapassa a fascia muscular. A criança pesa 20 quilogramas. Para a realização da sutura, dispõe-se de todo material cirúrgico e de duas apresentações de anestésico local: lidocaína a 1% sem vasoconstritor e lidocaína a 1% com vasoconstritor. A vacinação antitetânica está em dia. Após explicar o procedimento à paciente e à mãe, realizar

antisepsia e a colocação de campos cirúrgicos, a técnica anestésica mais adequada é

- A. A infiltrar a pele sadia ao redor do ferimento, utilizando lidocaína a 1% com vasoconstritor
- B. B infiltrar a pele sadia ao redor do ferimento, utilizando lidocaína a 1% sem vasoconstritor.
- C. C infiltrar o tecido subcutâneo por dentro da lesão, utilizando lidocaína a 1% com vasoconstritor
- D. D infiltrar o tecido subcutâneo por dentro da lesão, utilizando lidocaína a 1% sem vasoconstritor.

Questão 43

Anulada

ABC-SP 2020 ACESSO DIRETO

Dentre os fármacos abaixo, assinale a alternativa que contenha um bloqueador neuromuscular despolarizante:

- A. Pancurônio
- B. Atracúrio
- C. Succinilcolina
- D. Neostigmina

Questão 44

HIAE-SP 2023 ACESSO DIRETO

Um paciente de 49 anos está em sala operatória para ser operado por abdome agudo obstrutivo, secundário a neoplasia de cólon sigmoide. Comorbidades: obesidade, esteatose hepática e dislipidemia. Pulso: 98 bpm, PA: 120 x 70 mmHg, saturação de oxigênio: 97%, em ar ambiente. Foi internado com disfunção renal aguda, parcialmente revertida com hidratação. Creatinina: 1,5 mg/dL, K⁺: 4,3 mEq/L, hemoglobina: 11 g/dL. Para intubação orotraqueal para a cirurgia, considerando a escolha de utilizar a intubação de sequência rápida:

- A. Recomenda-se pré-oxigenação adequada.
- B. Está contraindicado o uso de bloqueador neuromuscular.
- C. A principal medida de preparação é a pré-ventilação com bolsa-valva-máscara (ambu).
- D. A manobra de Sellick deve ser evitada.

Questão 45

PSU-MG 2016 ACESSO DIRETO

Em relação à aplicação da máscara laríngea no trauma é ERRADO afirmar:

- A. Pode ser empregada nos casos de insucesso da intubação orotraqueal.
- B. Quando o doente chegar ao serviço de emergência utilizando uma máscara laríngea, o médico deve providenciar via aérea definitiva.
- C. Sua aplicação é simples e não exige treinamento específico.
- D. Tem papel estabelecido no tratamento dos doentes com via aérea difícil.

Questão 46

FAMERP 2020 ACESSO DIRETO

Paciente de 65 anos de idade, admitida em unidade de emergência do Hospital de Base por quadro de dispneia há 2 dias associada a tosse produtiva com expectoração com aspecto purulento. Raio-X de tórax evidenciou imagem de hipodensidade em lobo médio e inferior direito. Foi-lhe prescrito ceftriaxone e claritromicina. Paciente evoluiu com piora do padrão respiratório e hipotensão (pressão arterial média de 50mmHg). Foi indicada intubação orotraqueal (IOT) em Sequência Rápida uma vez que não haviam preditores de via aérea difícil. Levando-se em consideração o perfil de ação hemodinâmica das drogas abaixo, assinale a melhor opção a ser utilizada como droga sedativa para proceder à IOT:

- A. Quetamina
- B. Midazolam
- C. Propofol
- D. Fentanil

Questão 47

SURCE 2022 ACESSO DIRETO

Qual das seguintes características abaixo sugere uma via aérea difícil de ventilar/entubar?

- A. Abertura da boca de 6 cm.
- B. Cirurgia de artrodese cervical.
- C. Distância tireomentoniana aumentada.

D. Visualização da úvula, no teste de Mallampati.

Questão 48

UNIFESP 2024 ACESSO DIRETO

Mulher, 55 anos de idade, é admitida na UTI para pós-operatório de exérese de glioblastoma multiforme em região frontal direita. O procedimento não teve intercorrências, mas havia muito edema cerebral. O neurocirurgião solicita a manutenção da sedação até a manhã do dia seguinte, quando será realizada uma tomografia computadorizada de crânio. Qual é a melhor conduta para sedação e analgesia no momento?

- A. Tiopental e fentanil.
- B. Midazolam e morfina.
- C. Tiopental e morfina.
- D. Propofol e fentanil.

Questão 49

UFMG 2015 ACESSO DIRETO

Paciente, 85 anos, cardiopata, politraumatizado, em choque classe IV, será submetido à cirurgia de emergência. Qual das drogas abaixo tem melhor indicação na indução anestésica?

- A. Propofol.
- B. Etomidato.
- C. Cetamina.
- D. Tiopental.
- E. Diazepam.

Questão 50

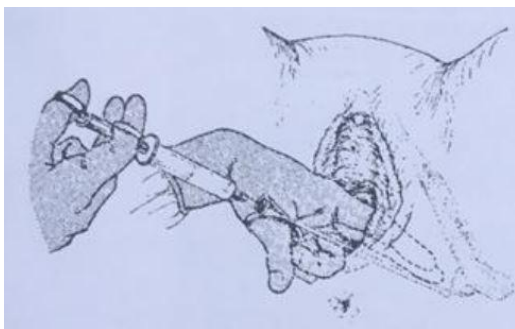
INEP 2022 REVALIDA

Uma criança com 5 anos de idade precisa ser submetida a um procedimento cirúrgico de pele. Considerando-se os agentes anestésicos locais, quais são os medicamentos, a serem administrados em associação, capazes de fornecer, respectivamente, o menor tempo de latência e o maior tempo de ação?

- A. Mepivacaína e lidocaína.
- B. Lidocaína e bupivacaína.
- C. Cloroprocaína e lidocaína.
- D. Cloroprocaína e mepivacaína.

Questão 51

USP-SP 2019 ACESSO DIRETO



Qual é a referência anatômica utilizada para realizar o procedimento anestésico representado na figura abaixo?

- A. Sínfese púbica.
- B. Linha íleo pectínea.
- C. Espinha isquiática.
- D. Forame obturatório.

Questão 52

ABC-SP 2017 ACESSO DIRETO

Na classificação de Mallampati, a visualização da úvula, palato mole, palato duro e pilares, é:

- A. I.
- B. II.
- C. III.
- D. C.

Questão 53

SES-DF 2023 ACESSO DIRETO

Uma paciente de 72 anos será submetida a uma cirurgia eletiva de histerectomia aberta e, para isso, passa por uma consulta pré-anestésica. Diante do caso, o anestesista opta em associar um bloqueio anestésico para a paciente. Com base no caso clínico e nos bloqueios anestésicos, julgue o item a seguir. Caso o anestesista aumente a dose de anestésico durante um bloqueio subaracnoide, geralmente irá causar aumento da extensão da dispersão cefálica e a duração do bloqueio.

- A. CERTO.
- B. ERRADO.

Questão 54

SCM-BH 2018 ACESSO DIRETO

Com relação às propriedades físico-químicas dos anestésicos locais, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A solubilidade lipídica é que determina a potência de um anestésico.
- B. A latência de um anestésico depende principalmente da sua concentração.
- C. Os anestésicos são ácidos fracos, solúveis em água.
- D. A duração de ação de um anestésico está relacionada a seu pKa.

Questão 55

UFCSPA 2026 ACESSO DIRETO

O midazolam é utilizado com frequência como indutor anestésico. Sobre essa medicação, avalie se as afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a sequência correspondente. () Na sedação adjunta à anestesia, usa-se 1 comprimido de 15mg, 30 a 60 minutos antes do procedimento. () Na retirada abrupta em pessoas que o utilizavam de forma crônica, podem ocorrer sintomas de abstinência, com duração de poucas horas a uma semana. () Sua eficácia como hipnótico ainda não é bem estabelecida. () Uma das suas reações mais comuns é a amnésia anterógrada.

- A. V - F - V - V.
- B. V - V - F - V.
- C. F - F - V - F.
- D. F - V - F - F.

Questão 56

UEPA 2022 ACESSO DIRETO

A insuficiência respiratória aguda é a principal indicação de ventilação mecânica na urgência. Com base nessa afirmação, a alternativa correta é:

- A. Mesmo em quadros de insuficiência respiratória em que a intubação traqueal estiver indicada, é recomendado iniciar ventilação não invasiva para evitar intubação.
- B. A gasometria arterial é pouco útil na diferenciação entre insuficiência respiratória aguda tipo 1 e tipo 2.

C. Pacientes em insuficiência respiratória aguda grave podem ser pronados por mais de 12h ao dia quando não houver contraindicação.

D. Em pacientes que necessitem de ventilação mecânica invasiva, valores da relação PaO_2/FiO_2 entre 150 e 250 mmHg são considerados normais.

E. Ao exame físico, frequência cardíaca acima de 130 bpm é o sinal mais frequentemente encontrado em pacientes com insuficiência respiratória aguda.

Questão 57

UNIFESP 2019 ACESSO DIRETO

Um paciente sob anestesia geral balanceada (inalatória + venosa) apresenta um índice bispectral reduzido ($=20$) e taxa de supressão do traçado do eletroencefalograma elevada. Qual dos abaixo corresponderia melhor a esses achados:

A. Paciente desperto e com parâmetros hemodinâmicos normais.

B. Paciente em profundidade anestésica excessiva e hipotensão arterial.

C. Paciente acordado durante a cirurgia e sob efeito de bloqueador neuromuscular.

D. Paciente em plano anestésico adequado numa cirurgia sem intercorrências.

E. Paciente em plano anestésico superficial, taquicárdico e com hipertensão arterial.

Questão 58

IAMSPE-SP 2020 ACESSO DIRETO

Em relação aos anestésicos locais, afirma-se: 1. São exemplos de anestésicos do grupo amida: tetracaína, lidocaína, bupivacaína e ropivacaína. 2. São bases fracas que carregam uma carga positiva no grupo amida, em pH fisiológico, tendo, portanto, sua ação prejudicada em meio ácido. 3. Seu mecanismo de ação é o bloqueio dos canais de cálcio nas membranas dos neurônios, sendo as fibras nervosas menores bloqueadas antes das fibras maiores. Em relação às afirmações, apenas:

A. 1 e 2 são corretas.

B. 2 e 3 são corretas.

C. 1 e 3 são corretas.

D. A 2 é correta.

E. A 1 é correta.

Questão 59

UFRJ 2024 ACESSO DIRETO

Estima-se a baricidade de uma solução de anestésico local dividindo-se a sua densidade pela densidade do líquido cefalorraquidiano (LCR) à 37°C. Pode-se afirmar, sobre a baricidade dos anestésicos locais, utilizados na raquianestesia, que:

A. A) Soluções de anestésicos locais preparadas em água possuem gravidade específica ligeiramente menor que o LCR e tendem a subir contra a gravidade.

B. B) Soluções hiperbáricas são menos densas que o LCR e tendem a seguir a gravidade após a injeção.

C. C) Soluções isobáricas são tão densas quanto o LCR e tendem a seguir a gravidade após a injeção.

D. D) A baricidade das soluções de anestésicos locais não é um fator determinante importante para o nível e duração da raquianestesia.

Questão 60

SUS-BA 2020 ACESSO DIRETO

Paciente, sexo feminino, 22 anos de idade, é trazida por familiares ao Pronto Socorro com história de ingestão de bebida alcoólica e droga ilícita (não sabem especificar a substância) durante uma festa, cursando com rebaixamento do nível de consciência e vômitos. Ao exame físico, regular estado geral, desorientada no tempo e no espaço, desidratada +2/+4, FC: 80bpm, PA: 118x74mmHg, FR: 24imp, ausculta cardíaca e respiratória sem alterações; Escala de coma de Glasgow 9 e pupilas midriáticas e fotorreagentes. O médico plantonista identificou condições preditoras de via aérea difícil nesta paciente. Indique qual conduta pode complicar a intubação orotraqueal.

A. Intubar com paciente acordada.

B. Utilizar laringoscopia videoassistida.

C. Utilizar dispositivos como guia (Bougie).

D. Intubar após sedação.

Questão 61

Paciente pós-cirúrgico cardíaco a céu aberto, em sala de recuperação, começa a acordar e falar que quer ajuda para descer do leito, pois quer conversar com seus amigos que estão no restaurante, onde costuma almoçar, no mercado público da cidade. Segundo os argumentos do paciente, estão próximos ao seu automóvel, para o qual aponta, como se estivesse efetivamente estacionado naquele andar do hospital. O médico procura tranquilizar o paciente, porém este, à medida que se recupera do processo cirúrgico e anestésico, fica cada vez mais agitado e agressivo. Sobre o caso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A.** A solicitação de exames laboratoriais como hemograma, provas de função hepática e renais, eletrólitos, entre outros, podem auxiliar na elucidação da origem do quadro clínico.
- B.** Trata-se de um quadro clínico característico de um paciente com Transtorno Delirante Tipo Somático prévio.
- C.** Trata-se de um Transtorno Neurocognitivo, no caso, um quadro de delirium, podendo ser decorrente tanto do processo cirúrgico e anestésico quanto de abstinência ou intoxicação por fármacos ou outras substâncias.
- D.** Este paciente apresenta, entre outras, alterações no nível de consciência, orientação e atenção.

Questão 62

HUOL 2021 ACESSO DIRETO

A queixa de dor é extremamente frequente em ambulatórios de atenção primária à saúde. Sua classificação auxilia o médico de família no manejo adequado. Sendo assim, uma paciente depressiva que apresenta dor devido a uma tendinopatia de punho, sem conseguir segurar objetos adequadamente, apresenta dor do tipo

- A.** Nociceptiva.
- B.** Neuropática.
- C.** Psicogênica.
- D.** Mista.

Questão 63

SMS-JP 2017 ACESSO DIRETO

A abordagem da dor crônica é um desafio cotidiano na Atenção Primária à Saúde, sendo fundamental entender seus componentes nociceptivo e neuropático. Considerando a abordagem mais moderna da neurociência, analise as afirmativas abaixo e assinale a letra contém somente as CORRETAS: I – A pessoa com dor crônica pode não apresentar uma lesão tecidual; II – A busca de lesão em exames de imagem é muitas vezes infrutífera; III – A pessoa deve se manter tão fisicamente ativa quanto possível e progressivamente aumentar seu grau de atividade

- A.** Somente II
- B.** Somente III
- C.** I e II
- D.** I e III
- E.** I, II e III

Questão 64

HUOL 2016 ACESSO DIRETO

Os conhecimentos sobre as propriedades e os efeitos colaterais dos anestésicos locais são essenciais para a formação médica. A opção em que há uma afirmação CORRETA sobre os anestésicos locais é:

- A.** A ropivacaína possui longa duração com alto potencial de cardiotoxicidade.
- B.** A bupivacaína possui metabolismo renal e duração muito lenta.
- C.** A lidocaína possui metabolismo hepático e início de ação rápido.
- D.** A procaína possui metabolismo plasmático e duração lenta.

Questão 65

HOS-SP 2024 ACESSO DIRETO

É indicado o uso de fentanil na fase de pré-intubação da técnica de intubação por sequência rápida em caso de:

- A.** Hipotensão arterial.
- B.** Hipertensão intracraniana.
- C.** Obesidade.
- D.** Idade avançada.

E. Hipoxemia.

Questão 66

UNIFESP 2024 ACESSO DIRETO

Mulher, 27 anos de idade, submeteu-se à colecistectomia por via laparoscópica, sob ventilação mecânica. Durante a manutenção da anestesia observa-se, na capnografia, queda progressiva do CO₂ expirado sem deformação da curva. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A. Insuflação excessiva do pneumoperitônio.
- B. Diminuição da pressão arterial.
- C. Aumento de resistência em vias aéreas.
- D. Recuperação do bloqueio neuromuscular.

Questão 67

HCPA-RS 2026 ACESSO DIRETO

Paciente masculino, de 42 anos, foi trazido à Emergência após envolver-se em uma colisão automobilística. À admissão, estava consciente, agitado e com respiração rápida. Apresentava dor abdominal intensa e sinais de hipoperfusão, com pressão arterial de 80/40 mmHg e frequência cardíaca de 130 bpm. Referiu ter se alimentado pouco antes do acidente. Diante do quadro de instabilidade e necessidade iminente de controle de via aérea, a equipe optou por realizar intubação com técnica de sequência rápida. Sobre a abordagem anestésica nesse contexto, assinale a assertiva correta.

- A. Ventilação com máscara facial deve ser realizada sistematicamente após a indução e antes da intubação, mesmo durante a sequência rápida, para garantir oxigenação adequada.
- B. Bloqueador neuromuscular deve ser administrado após a perda de consciência clínica, sem necessidade de monitor de profundidade anestésica.
- C. Pré-oxigenação não é imprescindível na sequência rápida, uma vez que o paciente já está hiperventilando espontaneamente.
- D. Succinilcolina está contraindicada na sequência rápida devido à possibilidade de fasciculações e aumento da pressão intracraniana.

Questão 68

ENARE 2023 ACESSO DIRETO

Sobre a dor, assinale a alternativa correta.

- A. Os nociceptores são responsáveis pela transdução.
- B. A dor neuropática tem como principal característica a melhora à noite e nos meses mais frios.
- C. A migrânea é um exemplo clássico de dor somática superficial.
- D. A pregabalina atua nos receptores opioides do sistema nervoso central, principalmente $\mu 1$ e $\mu 2$.
- E. A presença de injúria tecidual é essencial para a explicação do fenômeno doloroso.

Questão 69

SES-DF 2023 ACESSO DIRETO

Uma paciente de 72 anos será submetida a uma cirurgia eletiva de histerectomia aberta e, para isso, passa por uma consulta pré-anestésica. Diante do caso, o anestesista opta em associar um bloqueio anestésico para a paciente. Com base no caso clínico e nos bloqueios anestésicos, julgue o item a seguir. A raquianestesia consiste em uma alternativa a pacientes como a citada nesse caso, a depender do procedimento cirúrgico em questão, pois evita a manipulação da via aérea e as complicações da intubação traqueal.

- A. CERTO.
- B. ERRADO.

Questão 70

USP-RP 2025 ACESSO DIRETO

Homem, 52 anos, será submetido a colectomia subtotal devido a doença diverticular. O paciente tem hipertensão arterial e diabetes mellitus controlados com uso correto e regular de medicamentos. Qual a classificação pré-operatória desse paciente conforme os critérios de risco cirúrgico anestésico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)?

- A. Asa I.
- B. Asa III.
- C. Asa II.

Questão 71

ENARE 2022 ACESSO DIRETO

Um homem de 34 anos é levado ao serviço médico de urgência com história de ferimento por projétil de arma de fogo na coxa direita. Ele relata que estava fazendo limpeza e manutenção da sua arma, quando houve o disparo acidental. Relata que, durante alguns segundos, não sentiu nenhuma dor e logo chamou por ajuda. No momento da avaliação, refere dor intensa. Sobre a fisiopatologia da dor, assinale a alternativa correta.

- A. A temperatura elevada do projétil leva à inativação dos nociceptores de pele e estruturas mais profundas.
- B. A dor experimentada pelo paciente pode ser caracterizada como visceral verdadeira.
- C. A retirada do projétil é essencial para uma adequada analgesia.
- D. Dentro do componente sensitivodiscriminativo, a modulação tem papel importante nesse caso e tem função evolutiva de proporcionar um comportamento de luta e/ou fuga.
- E. A ausência de dor nos primeiros segundos após o acidente pode estar relacionada com o histórico do paciente (por exemplo: exmilitar).

Questão 72

UNESP 2020 ACESSO DIRETO

Criança de 3 meses foi submetida à cirurgia cardíaca para correção do defeito septal atrioventricular. A intubação e extubação orotraqueal ocorreram sem intercorrências. O tempo de intubação foi de três horas. Após a extubação, passou a apresentar choro baixo e fraco e leve estridor bifásico. Os sintomas mantiveram-se após uso de corticoide endovenoso. A hipótese diagnóstica é

- A. Estenose subglótica após intubação.
- B. Laringomalácia por malformação
- C. Paralisia de prega vocal esquerda por comprometimento do nervo laringeo recorrente.
- D. Laringite aguda viral sazonal.

Questão 73

UFES 2017 ACESSO DIRETO

Identifique o preditor de intubação traqueal difícil sob laringoscopia direta:

- A. Paciente edêntulo.
- B. Presença de barba espessa.
- C. Protrusão dos dentes incisivos maxiliares.
- D. Síndrome da apneia obstrutiva do sono.
- E. Obesidade moderada.

Questão 74

PSU-MG 2022 ACESSO DIRETO

Alguns adjuvantes são utilizados em associação aos anestésicos locais para melhorar a qualidade da anestesia durante o procedimento cirúrgico. Em relação a essa associação é CORRETO afirmar:

- A. A. A adrenalina aumenta o pH do local da cirurgia reduzindo a latência anestésica
- B. B. Em uma solução de anestésico local contendo adrenalina diluída em 1:400.000 temos 5,0mcg de adrenalina para cada 1,0ml da solução.
- C. C. Frascos de anestésicos local contendo adrenalina apresentam em geral pH mais ácido podendo ocasionar aumento na latência anestésica.
- D. D. O bicarbonato de sódio reduz o pKa do anestésico reduzindo a latência anestésica.

Questão 75

UFMA 2021 ACESSO DIRETO

Sobre o acesso intraósseo, assinale a alternativa INCORRETA:

- A. No acesso intraósseo pode ser ministrado os seguintes medicamentos: adrenalina, hemoderivados, soro fisiológico, antibióticos. Porém a via intraóssea não pode ser usada para coleta de exames.
- B. Os locais preferenciais de punção intraóssea são tibia proximal, a tibia distal e região distal do fêmur.
- C. A via intraóssea é uma excelente via de acesso vascular estando indicada para os quadros de choque descompensado resultante de qualquer etiologia (infeccioso, trauma, cardíaca, parada cardiorrespiratória e estado de mal convulsivo refratário).

D. São complicações possíveis do acesso intraósseo: êmbolo de gordura, infecção, extravasamento de medicações, fratura.

Questão 76

UNICAMP 2018 ACESSO DIRETO

Homem, 52a, com diagnóstico de espondilolistese com protrusão discal L5-S1, em uso de tramadol nas últimas 24 horas, foi submetido à cirurgia. Realizado midazolam no pré- anestésico, sendo a anestesia induzida com propofol, fentanil e rocurônio. Para prevenir vômitos, foi administrado ondansetrona e o bloqueio neuromuscular revertido com piridostigmina. Após extubação, queixou-se de náuseas, sendo administrado metoclopramida. Na reavaliação, o paciente apresentava desvio da visão para cima, rigidez muscular e pescoço fixo. Esses eventos são atribuídos a:

- A.** Ondansetrona e metoclopramida.
- B.** Rocurônio e piridostigmina.
- C.** Midazolam e tramadol.
- D.** Propofol e fentanil.

Questão 77

PSU-MG 2026 ACESSO DIRETO

Um cirurgião geral está preparando a mesa cirúrgica para realização de excisão de cisto de pele sob anestesia local, em paciente de 70 anos. O paciente tem histórico de doença arterial coronariana com colocação de stent e hipertensão arterial de difícil controle. O cirurgião opta por usar solução de anestésico local sem epinefrina. O acadêmico de medicina que estava acompanhando o cirurgião lhe questiona o motivo para o uso de anestésico sem epinefrina. Qual foi o argumento CORRETO que provavelmente o cirurgião utilizou para justificar sua escolha, neste caso?

- A.** A epinefrina altera o pKa do anestésico local aumentando a latência anestésica.
- B.** A epinefrina aumenta o pH do tecido, o que diminui a eficácia da anestesia local.
- C.** A epinefrina pode causar necrose tecidual em qualquer área do corpo, independentemente da condição do paciente.

D. A epinefrina pode ter efeitos sistêmicos, como o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial.

Questão 78

Anulada

UESPI 2022 ACESSO DIRETO

A respeito dos acessos venosos centrais é CORRETO afirmar:

- A.** A) A lesão pleural ocorre mais frequentemente nas punções para acesso à veia subclávia do que às da veia jugular interna.
- B.** B) A veia de escolha na dissecação venosa para um acesso central é a veia braquial direita devido à facilidade de acesso.
- C.** C) A punção da veia femoral, entre os acesso venosos centrais, tem menor incidência de complicações como por exemplo a infecção do sítio.
- D.** D) Em caso de forte suspeita de infecção do cateter central, este deve ser removido e enviado para cultura da ponta.
- E.** E) A veia jugular interna apresenta posição medial no pescoço e a artéria carótida comum situa-se lateralmente.

Questão 79

Anulada

ABC-SP 2024 ACESSO DIRETO

A administração intravenosa de Plasma Fresco Congelado, atualmente, é recomendada nas seguintes situações:

- A.** INR menor do que 1,5 ou se o tempo de protrombina (TP) e o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) estiverem abaixo de 60%.
- B.** Pacientes com doença hepática, com TP e TTPa minimamente alterados e com sangramento normal.
- C.** Pacientes com grave deficiência congênita de IgA circulante.
- D.** Reposição de volume, suporte nutricional e reposição de imunoglobulinas.
- E.** Presença de sangramento ativo ou se houver risco de sangramento em um procedimento de emergência.

Questão 80

A intubação de sequência rápida é a melhor técnica para a intubação na sala de emergência. Sobre este procedimento, assinale a resposta errada:

- A.** Preferencialmente os pacientes deverão estar com um acesso venoso de bom calibre, monitorizados de maneira completa disponível, inclusive com capnometria, embora na vida real, nem sempre isto seja completamente possível.
- B.** Sobre o material utilizado, os tubos devem ser os maiores possíveis, em média com diâmetro interno de 7,5 a 8,0 mm para as mulheres e 8,0 a 8,5 mm para os homens, e os laringoscópios com lâminas curvas são preferíveis nos adultos.
- C.** São indicações clássicas de intubação orotraqueal: fadiga da musculatura inspiratória em pacientes com risco de broncoaspiração, obstrução de vias aéreas, hipoxemia refratária, trabalho respiratório intenso, instabilidade hemodinâmica grave, proteção de vias aéreas, entre outras.
- D.** As principais alterações ocorridas durante a laringoscopia e intubação orotraqueal são; aumento de pressão intracraniana, aumento de fluxo sanguíneo cerebral, aumento da resistência das vias aéreas, arritmias ventriculares, broncoconstrição, etc.
- E.** A intubação nasotraqueal, tem como principais indicações, pacientes em parada cardiorrespiratória com intubação difícil causada por trauma craneano com fratura em base do crânio, nos quais hiperextensão do pescoço constitui-se uma técnica arriscada.

Questão 81

SUS-BA 2019 ACESSO DIRETO

Imagem do exame contrastado



Paciente, 52 anos de idade, sexo masculino, iniciou há 8 meses com disfagia, ora para sólidos ora para alimentos líquidos. Refere aumento da intensidade dos sintomas nos últimos meses, com perda ponderal de 5kg no período. Nega dor, febre ou outras queixas. Ao exame físico apresenta regular estado geral, emagrecido. Abdome escavado, indolor à palpação, sem visceromegalias. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios. Distância tiromentoniana 6,5cm, distância esterno-mento 11cm, distância interincisiva 3cm. Classificação de Mallampati 2. Realizado exame contrastado. Os sinais a serem observados para determinar dificuldade de intubação orotraqueal, nesse paciente, são

- A.** Classificação de Mallampati e distância tiromentoniana.
- B.** Distância interincisiva e classificação de Mallampati.
- C.** Distância interincisiva e distância tiromentoniana.
- D.** Distância interincisiva e distância esterno-mento

Questão 82

USP-RP 2019 ACESSO DIRETO

Homem de 45 anos, hepatopata, foi admitido com quadro de hematemese volumosa com instabilidade hemodinâmica. Puncionado acesso venoso periférico para a reanimação inicial, porém, agora necessita de outro acesso venoso para administração de aminas vasoativas e monitorização venosa central. Exames laboratoriais - hemoglobina: 9,5 g/dL; hematócrito: 30%; creatinina: 1,0 mg/dL; ureia: 40 mg/dL; plaquetas: 30.000

cel/mm³ tempo de protrombina (INR): 1,8; tempo de tromboplastina parcial ativada: 40 s. Qual é a melhor opção de acesso venoso dentre as alternativas abaixo?

- A. Punção de veia jugular interna.
- B. Dissecção de veia axilar.
- C. Dissecção de veia safena magna.
- D. Punção de veia jugular externa.

Questão 83

UERN 2020 ACESSO DIRETO

Uma criança de 7 anos de idade é submetida a laparotomia exploradora para esclarecimento diagnóstico de dor abdominal. Após cerca de 30 minutos do início da anestesia, nota-se hiperpirexia (42 °C), taquicardia, rigidez e cianose. Exames laboratoriais revelam hipercalcemia, hipercalcemia e acidose metabólica. O diagnóstico mais provável para essa condição é:

- A. Síndrome maligna associada aos neurolépticos.
- B. Reação anafilática.
- C. Hipertermia maligna.
- D. Processo infeccioso não diagnosticado no pré-operatório.

Questão 84

Anulada

PSU-MG 2019 ACESSO DIRETO

Em relação aos anestésicos locais, assinale a alternativa CORRETA:

- A. A associação da adrenalina aos anestésicos locais geralmente aumenta sua toxicidade sistêmica.
- B. A bupivacaína é contraindicada para anestesia peridural em decorrência de seu efeito vasoconstritor.
- C. A bupivacaína, quando aplicada em baixas doses, proporciona principalmente bloqueio motor.
- D. Apesar de terem afinidades proteicas semelhantes, a ropivacaína apresenta maior duração de ação que a bupivacaína.

Questão 85

HUOL 2018 ACESSO DIRETO

O conhecimento da farmacologia dos anestésicos locais é de essencial importância para o médico generalista, pois seu uso inadequado pode levar a graves consequências. Sobre esse tipo de anestésico, é correto afirmar:

- A. Os injetáveis por via intravenosa diminuem o limiar à dor e causam hiperestesia.
- B. A dormência periodontal e lingual é um sintoma precoce de intoxicação do sistema nervoso central.
- C. A lidocaína e a procaína têm propriedades anticonvulsivantes quando ministradas em baixas doses.
- D. Os do tipo amida são os de maior risco para desenvolvimento de hipertermia maligna.

Questão 86

UNESP 2023 ACESSO DIRETO

Homem de 70kg, será submetido a anestesia infiltrativa para exérese de pequeno lipoma em abdome. A dose máxima permitida de lidocaína que pode ser utilizada durante o procedimento é:

- A. 17,5 ml de lidocaína 2% sem vasoconstritor.
- B. 30 ml de lidocaína 2% com vasoconstritor.
- C. 21 ml de lidocaína 1% sem vasoconstritor.
- D. 17,5 ml de lidocaína 2% com vasoconstritor.

Questão 87

HCPA-RS 2022 ACESSO DIRETO

Paciente de 38 anos, com IMC de 48 kg/m², será submetido a gastroplastia videolaparoscópica eletiva. Feita a indução anestésica, o anesthesiologista realizou 3 tentativas de intubação sem sucesso. Após a terceira tentativa, foram identificados sangramento e edema na via aérea. A ventilação sob máscara facial era factível, e a saturação arterial de oxigênio permanecia em 94%. Assinale a alternativa que contempla a conduta mais apropriada para o caso.

- A. Chamar anesthesiologista mais experiente para tentar realizar a intubação.
- B. Inserir máscara laríngea e, caso bem posicionada, seguir o planejamento cirúrgico.
- C. Realizar cricotireoidostomia.

D. Acordar o paciente e planejar intubação por fibrobroncoscopia em outro momento.

Questão 88

UNIFESP 2024 ACESSO DIRETO

Secundigesta, 36 semanas de gestação, foi internada às 18 horas em trabalho de parto prematuro com 5cm de dilatação cervical. Refere ter feito uso de enoxaparina sódica na dose de 40mg/dia, durante toda a gestação, por ser portadora de trombofilia hereditária. Última aplicação ocorreu as 8 horas da manhã do mesmo dia. Durante o período expulsivo do parto, às 22 horas, há indicação de cesárea por desacelerações tardias recorrentes. Qual é a técnica anestésica mais indicada?

- A. Peridural.
- B. Anestesia geral.
- C. Duplo bloqueio (raquianestesia + peridural).
- D. Raquianestesia.

Questão 89

ABC-SP 2017 ACESSO DIRETO

Droga de escolha para tratamento da hipertermia maligna:

- A. Soro fisiológico.
- B. Adrenalina.
- C. Amiodarona.
- D. Dantrolene sódico.

Questão 90

USP-SP 2022 ACESSO DIRETO



Homem de 65 anos de idade é admitido por insuficiência respiratória aguda no Pronto-Socorro. Durante o atendimento inicial, evolui com piora do padrão respiratório e da hipoxemia, optando-se por intubação orotraqueal. Nesse momento, a frequência respiratória é de 40 irpm, saturação de oxigênio de 88% com máscara não reinalante a 15L/min,

frequência cardíaca de 120bpm e pressão arterial de 60x30 mmHg. Após a intubação orotraqueal, a capnografia mostra a seguinte curva: Qual é o diagnóstico mais provável?

- A. Intubação esofágica.
- B. Pneumotórax.
- C. Intubação seletiva.
- D. Broncoespasmo.

Questão 91

FAMEMA 2025 ACESSO DIRETO

Homem, 62 anos, portador de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) sintomática, pouco controlada e hipertensão arterial sistêmica (HAS), não medicada, procura ajuda médica por apresentar hérnia incisional sintomática. Diante da indicação de tratamento cirúrgico para correção desta hérnia, o médico cirurgião solicita ao anestesista uma avaliação do risco cirúrgico, segundo o consagrado sistema de classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA). Com base nas informações do enunciado, esse paciente está estratificado como:

- A. ASA 2.
- B. ASA 1.
- C. ASA 4.
- D. ASA 3.

Questão 92

UNIFESP 2022 ACESSO DIRETO

Homem, 55 anos de idade, ASA I, está no 2º PO de hernioplastia inguinal bilateral, realizada sob raquianestesia em punção lombar, com bupivacaína e morfina. Apresenta náuseas, prurido no abdômen e membros inferiores, intensa cefaleia occipital e temporal, irradiando para a região cervical, com piora na posição sentada ou ortostática. Sinais vitais: PA 130 x 90 mmHg e FC = 100 bpm. Qual é a conduta inicial mais adequada?

- A. Tampão sanguíneo peridural e opioide.
- B. Corticoide e dipirona.
- C. Hidratação e dipirona.
- D. Metoclopramida e opioide.

Questão 93

Anulada

UFMA 2021 ACESSO DIRETO

Paciente do sexo feminino, 38 anos de idade, com massa corpórea de 111 kg, apresenta-se para excisão cirúrgica de feocromocitoma, para a qual já recebeu um curso de 14 dias de fenoxibenzamina. A programação é realizar anestesia epidural e geral combinadas. O agente MENOS aconselhado para manutenção da anestesia é:

- A. Desflurano
- B. Isoflurano
- C. Propofol
- D. Sevoflurano

Questão 94

SES-PE 2018 ACESSO DIRETO

"Mulher, 30 anos, submetida à hernioplastia incisional com acesso de Pfaniestiel sob raqui-anestesia. Na manhã do 1º DPO, a paciente apresenta cefaleia intensa que piora com tosse, espirro e movimentos da cabeça. Em relação à condição clínica acima, qual dos tratamentos abaixo NÃO deve(m) ser indicado(s)?"

- A. Analgésicos, como dipirona
- B. Hidratação
- C. Deambulação precoce
- D. Cafeína
- E. Blood patch

Questão 95

ENARE 2023 ACESSO DIRETO

Um paciente foi submetido a uma cirurgia abdominal, e o anestesista introduziu um cateter peridural para analgesia. O paciente se encontra na UTI utilizando heparina de baixo peso molecular como anticoagulação profilática, e a enfermeira questiona o médico plantonista se pode retirar o cateter. Nesse caso, qual é a conduta mais adequada e a respectiva justificativa?

- A. Retirar o cateter, já que a anticoagulação profilática não interfere no risco para hematoma epidural.

B. Manter o cateter e solicitar orientação ao anestesista quanto ao momento da retirada, devido ao risco de hematoma epidural.

C. O cateter poderá ser removido se a última dose de heparina tiver sido realizada há mais de 3h.

D. Manter o cateter e aguardar, pelo menos, 48h, após a última dose da heparina para remover o cateter.

E. Manter o cateter por, pelo menos, 24h, após a última dose de heparina devido ao risco de hematoma subdural.

Questão 96

DANTE 2024 ACESSO DIRETO



Homem de 34 anos de idade é admitido na unidade de emergência com quadro de insuficiência respiratória aguda, devido a quadro grave de COVID-19. É indicada a realização de intubação orotraqueal e, após a sedação e administração de bloqueador neuromuscular, é feita a primeira tentativa de laringoscopia. Durante este procedimento, o paciente mantém saturação de oxigênio estável e o médico visualiza as estruturas visíveis na figura a seguir, na laringoscopia direta: Qual é o próximo passo que deve ser adotado para realização da intubação?

- A. Introduzir o tubo orotraqueal utilizando as estruturas visualizadas como guia.
- B. Utilizar uma cânula orofaríngea para manter a abertura da via aérea.
- C. Utilizar um guia (Bougie) para auxiliar na intubação orotraqueal.
- D. Abortar a tentativa de intubação e indicar realização de cricotireoidostomia.

Questão 97

UFCG 2019 ACESSO DIRETO

Sobre as complicações de acesso venoso central, é INCORRETO afirmar que:

- A. Sepses por cateter deve ser tratado com a remoção do cateter e com antibiótico venoso com cobertura para *Streptococcus* e *Candida*.
- B. A punção de veia jugular interna apresenta maior incidência de complicação infecciosa do que a punção de veia subclávia.
- C. Punção de veia femoral está associada a uma maior taxa de complicações tromboembólicas.
- D. A punção de veia subclávia está associada a maior taxa de complicação mecânica do que a punção de veia jugular interna.
- E. A punção de veia jugular interna à esquerda, pode ter como complicação fistula quilosa, devido a punção inadvertida do ducto torácico linfático.

Questão 98

UNIFESP 2023 ACESSO DIRETO

Mulher, 85 anos de idade, pesando 45 kg, e com 1,65m de altura. Será submetida a desbridamento e troca de curativo à vácuo em membro inferior esquerdo. Tem antecedente de AVC isquêmico e síndrome coronariana aguda. É optado por realização de raqui-anestesia com punção entre L2-L3. Em relação ao anestésico local e técnica para raqui-anestesia. Qual é a conduta adequada?

- A. A. Utilizar 10 mg de bupivacaína 0,5% isobárica mantendo o paciente sentado por 5 min após a punção.
- B. B. Utilizar 10 mg de bupivacaína 0,5% isobárica colocando o paciente em decúbito dorsal logo após a punção.
- C. C. Utilizar 20 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica colocando o paciente em decúbito dorsal logo após a punção.
- D. D. Utilizar 20 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica colocando o paciente em decúbito lateral direito logo após a punção.

Questão 99

UNESP 2018 ACESSO DIRETO

A toxicidade ao sistema nervoso central pela administração de anestésicos locais é:

- A. Reduzida devido à diminuição da ligação dessas drogas às proteínas plasmáticas.
- B. Relacionada a efeitos excitatórios resultantes, frequentemente, das baixas concentrações plasmáticas dessas drogas.
- C. Caracterizada por efeitos excitatórios se as drogas forem lipofílicas e estiverem em altas concentrações plasmáticas.
- D. Manifestada, por exemplo, por convulsão, sendo que o limiar convulsivo pode ser aumentado pela administração de benzodiazepínicos.

Questão 100

UNICAMP 2022 ACESSO DIRETO

Lactente, 18m, sofreu trauma na face. Exame físico: Escala de Coma de Glasgow = 15; face: ferimento cortocotuso perilabial. A conduta é de sutura simples. A DROGA INDICADA PARA SEDOANALGESIA PARA O PROCEDIMENTO É:

- A. A. Midazolam.
- B. B. Cetamina.
- C. C. Meperidina.
- D. D. Propofol.

Questão 101

AMRIGS 2025 ACESSO DIRETO

Criança de 4 anos, no transoperatório de adenoidectomia, faz hipertermia de 41°C e apresenta baixo débito cardíaco. Imediatamente, é administrado dantroleno, pois inferiu-se corretamente que o gatilho foi:

- A. Translocação bacteriana.
- B. Infarto agudo do miocárdio.
- C. Hipertermia maligna pelo uso de succinilcolina.
- D. Sangramento nasal, em decorrência de Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD).

Questão 102

UNESP 2022 ACESSO DIRETO

Homem de 65 anos necessita de correção emergencial de fratura exposta e lesão vascular em membro superior esquerdo, com tempo cirúrgico estimado de 4 horas. AP: HAS, DM, obesidade grau II, roncos e sonolência durante o dia, dificuldade no manejo de via aérea em cirurgias anteriores. Exame físico: ansioso, PA 140/90 mmHg, edêntulo, com pequena abertura bucal (menor que 3,5 cm) e espaço submandibular firme à palpação. Última refeição há 3 horas. A conduta mais indicada é:

- A. A. suspender o procedimento até que o tempo de jejum para sólidos seja de 8 horas.
- B. B. realizar indução e intubação sob sequência rápida, O₂ evi02 tando ventilação sob pressão positiva durante etapa de pré-oxigenação.
- C. C. proceder com realização da cirurgia sob sedação e infiltração local, para que se evite manipulação das vias aéreas.
- D. D. prosseguir com intubação via fibroscopia óptica com paciente acordado e mantendo reflexos protetores de via aérea, antes de indução da anestesia geral.

Questão 103

UERN 2023 ACESSO DIRETO

Intubação brônquica seletiva dos brônquios fonte direito ou esquerdo pode ocorrer facilmente durante a intubação em crianças porque:

- A. A traqueia é relativamente curta.
- B. A distância dos lábios até a laringe é relativamente curta.
- C. O uso de tubos endotraqueais com cuff elimina esse problema.
- D. Os brônquios fontes são menos angulados em relação à traqueia.

Questão 104

SCM-SP 2022 ACESSO DIRETO

Um paciente foi admitido no pronto-socorro com quadro clínico de choque séptico de foco pulmonar. Foram indicadas a administração de noradrenalina e a passagem de acesso venoso central

em veia jugular interna direita, pela via central. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a punção envolve a localização do marco anatômico, no ápice do triângulo formado pela(s)

- A. Cabeças do músculo esternocleidomastóideo e pela clavícula.
- B. Cabeças do músculo esternocleidomastóideo e pelo músculo platisma.
- C. Cabeças do músculo platisma e pela clavícula.
- D. Inserção do músculo escaleno e pelo músculo trapézio.
- E. Inserção medial do músculo esternocleidomastóideo e pelo músculo escaleno.

Questão 105

UFCSPA 2024 ACESSO DIRETO

A malácia da via aérea (traqueo/broncomalácia) é um diagnóstico relativamente comum na população pediátrica. A visualização direta da via aérea por fibrobroncoscopia é a melhor opção para confirmação diagnóstica nos casos com sintomatologia mais grave. Neste contexto, assinale a alternativa CORRETA quanto à técnica anestésica a ser utilizada:

- A. Plano anestésico profundo, sem movimentos ventilatórios e sem reflexo de tosse para minimizar o risco de dano à via aérea.
- B. Plano anestésico profundo, sem movimentos ventilatórios, mas com reflexos de tosse preservados.
- C. Anestesia/sedação com ventilação espontânea preservada e movimentos respiratórios profundos.
- D. Anestesia/sedação com ventilação espontânea superficial e sem estímulos reflexos de tosse.

Questão 106

UNICAMP 2016 ACESSO DIRETO

O período de jejum para leite materno exclusivo preconizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia é de:

- A. Duas horas.
- B. Quatro horas.

C. Seis horas.

D. Oito horas.

Questão 107

PUCSP 2023 ACESSO DIRETO

Um homem de 65 anos é submetido a uma laparotomia diagnóstica por obstrução intestinal. Minutos após a indução, o paciente torna-se hipotenso com pressão arterial de 65/45 mmHg. Qual é o próximo passo?

- A. Administrar 2 unidades de concentrado de hemácias.
- B. Iniciar gotejamento de dopamina em dose baixa e 500 mL de solução salina.
- C. Realizar massagem cardíaca externa.
- D. Interromper a anestesia e ventilar com oxigênio.

Questão 108

HUOL 2017 ACESSO DIRETO

As substâncias vasoconstrictoras são utilizadas, frequentemente, em associação com os anestésicos locais. Associadas a esses anestésicos, as substâncias vasoconstrictoras:

- A. Aumentam a toxicidade dos anestésicos locais.
- B. Desempenham papel protetor de complicações.
- C. Aumentam a incidência de hemorragia.
- D. Diminuem a intensidade do efeito anestésico.

Questão 109

UFMT 2015 REVALIDA

Sobre os princípios de tratamento da dor aguda, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A. A resposta endocrinometabólica ao stress não é benéfica na tentativa de recuperação do paciente.
- B. A dor aguda está relacionada à instalação de um processo patológico, seja ele de origem traumática ou inflamatória
- C. A dor aguda produz liberação de neuro-hormônios adrenérgicos em resposta à agressão.

D. A dor desencadeia diminuição da motilidade da uretra e da bexiga, com consequente dificuldade para urinar.

Questão 110

UNESP 2021 ACESSO DIRETO

Homem de 25 anos apresenta queixas inespecíficas de dor generalizada há 1 ano. Essa dor é contínua, profunda e superficial, não se limitando a uma estrutura, sem fatores de melhora ou piora identificados. Realizou extensa investigação diagnóstica sem nenhuma alteração. AP: fadiga e sono não reparador há anos. Em relação ao diagnóstico desse paciente, podemos afirmar que se trata de dor

- A. Nociceptiva.
- B. Neuropática.
- C. Nociplástica.
- D. Psicogênica.

Questão 111

SUS-SP 2015 ACESSO DIRETO

Um paciente de 40 anos de idade está no quarto pós-operatório de hernioplastia inguinal direita à Lichtenstein, feita sob raquianestesia. Queixa-se de muita cefaleia e de vômitos frequentes. Está descorado e desidratado. A ferida operatória tem discreta hiperemia. Nega dor abdominal. Conduta mais apropriada:

- A. Blood patch.
- B. Benzodiazepínicos e analgésicos.
- C. Analgésicos e antibioticoterapia tópica.
- D. Antibioticoterapia oral.
- E. Suspensão de opioides prescritos e reforço com analgésicos simples, mais frequentes.

Questão 112

USP-SP 2024 ACESSO DIRETO

Homem, 25 anos, deu entrada no Serviço de Emergência com ferimento cortocotuso no 3º quirodáctilo direito (QDD) de 3 cm. Opta-se pela realização de um bloqueio troncular na base do 3º QDD para realizar a sutura do ferimento. Assinale a alternativa que apresenta o anestésico mais indicado.

- A. Ropivacaína.
- B. Benzocaína.
- C. Lidocaína sem vasoconstritor.
- D. Bupivacaína com vasoconstritor.

Questão 113

AMRIGS 2022 ACESSO DIRETO

Ferimento cortocontuso em extremidade do dedo da mão com sangramento profuso e intenso. Em relação à anestesia local, como proceder?

- A. Bloqueio troncular com lidocaína e vasoconstritor.
- B. Infiltração local com lidocaína com vasoconstritor.
- C. Bloqueio troncular com lidocaína sem vasoconstritor.
- D. Infiltração local com lidocaína sem vasoconstritor

Questão 114

ABC-SP 2022 ACESSO DIRETO

Considere que as drogas para sedação e analgesia foram muito utilizadas durante o período da pandemia da covid-19. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A. O início da ação do etomidato é imediato (15 – 45 segundos).
- B. A duração do efeito da quetamina é, em geral, de 30 a 60 minutos.
- C. A infusão do fentanil deve ocorrer em até 10 minutos após a indução.
- D. O uso do midazolam está indicado quando se deseja o máximo de sedação.
- E. O propofol é a única droga que pode causar sedação e analgesia com manutenção da respiração espontânea.

Questão 115

UESPI 2022 ACESSO DIRETO

Um médico na sala de cirurgia ambulatorial faz o planejamento de um procedimento de pequeno porte. Trata-se de um paciente do sexo masculino, com 30 anos, sem comorbidades ou alergia

a medicamentos. Conclui que pode utilizar no máximo 400mg de lidocaína e precisa diluir a lidocaína 2% em 20ml disponível, até uma concentração de 0,5% para obter anestésico suficiente para o procedimento, sem ultrapassar a dose máxima segura. Assinale a alternativa CORRETA.

- A. A) Preenchendo uma seringa de 20ml com lidocaína 2% e diluente na proporção de 1 para 1, podendo obter até 2 seringas a 0,5% do anestésico para o procedimento
- B. B) Preenchendo uma seringa de 20ml com lidocaína 2% e diluente na proporção de 1 para 2, podendo obter até 3 seringas a 0,5% do anestésico para o procedimento.
- C. C) Preenchendo uma seringa de 20ml com lidocaína 2% e diluente na proporção de 1 para 3, podendo obter até 4 seringas a 0,5% do anestésico para o procedimento.
- D. D) A diluição da mesma quantidade de soluto de lidocaína com concentração inicial de 2% para uma a 0,5% não tem vantagem quanto à diminuição da sua toxicidade.
- E. E) O uso de lidocaína com vasoconstritor não interfere na dose tóxica do anestésico local.

Questão 116

PUC-PR 2024 ACESSO DIRETO

Sobre a técnica de punção de um acesso venoso central guiada por ultrassonografia, assinale a CORRETA.

- A. Na técnica dinâmica, deve-se realizar a medida da profundidade do vaso e então posicionar a agulha em um ângulo de 30 graus com a pele, entrando em linha reta sem a visualização direta da agulha.
- B. O primeiro passo deve ser o reconhecimento das estruturas anatômicas, podemos diferenciar a veia jugular interna da artéria carótida realizando a compressão dos vasos. Nessa manobra espera-se que a artéria colabe durante a compressão.
- C. O acesso de escolha para uso da técnica guiada por Ultrassonografia deve ser a veia subclávia, uma vez que está associado a menores taxas de complicações e de punção arterial inadvertida.
- D. Na técnica estática, deve-se posicionar a veia no

centro do monitor e realizar a inserção da agulha em um ângulo de 45 graus em relação ao transdutor e equidistante deste com a veia.

E. A punção guiada por ultrassom dispensa o uso de técnica asséptica, uma vez que reduz o número de tentativas de punção.

Questão 117

HOS-SP 2023 ACESSO DIRETO

Em relação à hipertermia maligna (HM), é correto afirmar que:

- A. É uma crise hipermetabólica potencialmente fatal que se manifesta somente durante a exposição a um anestésico geral deflagrador em indivíduos suscetíveis.
- B. Agentes anestésicos de inalação halogenados e relaxantes musculares despolarizantes causam uma diminuição na concentração de Ca^{2+} mioplásmico.
- C. Quando indivíduos suscetíveis a HM são expostos a um anestésico deflagrador, ocorre a liberação anormal de Ca^{2+} , provocando ativação prolongada dos filamentos musculares, culminando com flacidez muscular e hipometabolismo.
- D. Suspeita-se de suscetibilidade à HM no pré-operatório em pacientes com histórico familiar de HM ou histórico pessoal de mialgia após exercício, tendência ao desenvolvimento de febre, doença muscular e intolerância à cafeína.
- E. O dantrolene é anestésico inalatório que, com maior incidência, desencadeia o desenvolvimento de HM em pacientes suscetíveis.

Questão 118

Anulada

UFES 2016 ACESSO DIRETO

No atendimento ao paciente traumatizado quando abordamos a via aérea, é considerada uma via aérea definitiva, exceto:

- A. Tubo nasofaríngeo.
- B. Cricotireoidostomia.
- C. Traqueostomia.
- D. Tubo nasotraqueal.
- E. Máscara laríngea.

Questão 119

UEPA 2025 ACESSO DIRETO

Uma mulher de 35 anos de idade, é admitida na unidade de terapia intensiva com taquicardia sinusal, taquipneia, hipotensão arterial e temperatura axilar de 39.5°C após colecistectomia videolaparoscópica eletiva. No exame físico é notável a rigidez muscular generalizada. No eletro presença de ondas T pontiagudas, desaparecimento das ondas P, alargamento do QRS e raras extrasístoles ventriculares. O medicamento que deve ser administrado imediatamente é:

- A. Noradrenalina.
- B. Paracetamol.
- C. Dantrolene.
- D. Hidrocortisona.
- E. Aspirina.

Questão 120

SURCE 2024 ACESSO DIRETO

Esse gás anestésico apresenta as seguintes características: baixo indutor de depressão cardíaca e respiratória, possui rápido adormecer e despertar, não deve ser usado como substância única na manutenção de anestesia profunda, está associado a náuseas e vômitos pós-anestésicos e é frequentemente utilizado para sedação consciente. A qual dos seguintes gases anestésicos essas características se refere?

- A. Éter.
- B. Halotano.
- C. Isoflurano.
- D. Óxido Nitroso.

Gabarito

anestesia 2

03 de Outubro de 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	C	C	C	C	B	B	B	D	C	D	D	C	B

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	B	B	B	C	B	A	C	E	B	C	A	A	-

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
D	C	A	B	C	D	D	D	D	B	D	B	-	A	C

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	B	D	B	B	C	A	A	A	B	C	B	D	A	D

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
B	A	E	C	B	B	B	A	A	C	D	C	C	C	A

76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	-	-	E	D	D	C	-	C	A	D	D	D	A

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
C	C	-	C	B	C	A	B	D	B	C	D	A	A	C

106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	D	B	A	C	A	C	C	A	C	D	D	-	C	D